EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 96017
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2024-10-29 10:20:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: IRENIA DE LAS NIEVES JARA SAEZ			RUN	: 8.247.770-5
F.Nac	: 03-08-1953	Edad	: 71 AÑOS, 2 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: P.DEL SUR S.CORREA 0615			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 74025201		
Fecha Ingreso	: 2024-10-17	Fecha Egreso	: 2024-10-29 10:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R10.3-DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R10.0-ABDOMEN AGUDO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente consulta en SU el 07/10 por cuadro de dolor abdominal de 3 días de evolución, estudio realizado concluye cuadro de Diverticulitis aguda, con flegmon, sin colecciones, fue ingresada a Servicio de cirugía, con esquema antibiótico empírico, con ceftriaxona + metronidazol.
Presenta evolución tórpida, con parámetros inflamatorios aumentados y tendencia a hipotensión, por lo que el día 16/10 se cambia esquema antibiótico a Tazonam . TC AP (14/10) muestra Colecciones hidroaéreas abdomino pelviana 10.5 x 9 cm. Ingresa a pabellón el 17/10/24 para Laparotomía exploradora, con colección de aspecto fecaloídeo 600 cc y otra de 300 cc (se toma cultivo), se realizó resección de colon sigmoides y colostomía por flanco izquierdo. Además con drenaje tubular .
Durante intraoperatorio con requerimiento de NAD hasta 0.06 mg/kg/min, además se transfundió 1 U GR y 2 U de PFC. Destaca FA con RVR en monitorización.
Egresa a UTI con buena evolución, control con exámenes en normalización, realimentación bien tolerado, sin nauseas ni vómitos, tránsito conservado.
Se traslada a nuestro servicio permaneciendo con buena evolución, hoy afebril, eupneica, régimen bien tolerado, sin nauseas ni vómitos. Destaca al examen seroma en drenaje desde herida e laparotomía, sin otras alteraciones.
En base a buena evolución y estabilidad hemodinámica se da alta hospitalaria por servicio de hodom para continuar con recuperación y seguimiento de forma ambulatoria

PLAN DE MANEJO:

Analgesia
Mantener ATB
Reposo
Curaciones

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen liviano
3. METAMIZOL COMPRIMIDO 300 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL

4. METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 14 dias via ORAL
5. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 14 dias via ORAL
6. AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. LINEZOLID 600 MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 12 hrs. por 14 dias via ORAL
8. FLUCONAZOL CAPSULA 150 MILIGRAMOS 1 capsula cada 24 hrs. por 7 dias via ORAL
9. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
10. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
11. DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
12. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 14 dias via ORAL
13. Curaciones con irrigación
14. KNT respiratoria y motora
15. Consultar en urgencias sos
16. Control en policlínico de cirugía en 2 semanas

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

PATRICIO ALEXIS JARA VILLA
MEDICO TRATANTE
17346122-4

JEFE SERVICIO